

Datei: 05-mail-dienststelle-fuersorge.eml

Von	Dienstgruppenleitung <leitung@nordhafen-polizei.example>
An	Personalstelle <personal@nordhafen-polizei.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Karla Behrens / Wiedereingliederung und Einsatzplanung

Hallo,

Karla möchte wiederkommen, aber bitte nicht sofort in die Nachtschichten. Ich halte sie für belastbar, wenn wir das vernünftig machen. Was nicht geht: erst sagen, psychisch ist das privat, und sie dann im nächsten Satz wieder in Gefahrgut schicken. Das versteht niemand in der Gruppe.

Bitte klärt auch, ob die Therapiekosten jetzt über Unfallfürsorge, Beihilfe oder PKV laufen. Sie hängt seit Monaten zwischen den Systemen.

Gruß

Marten

Datei: 12-email-arzt-an-dienststelle-belastungsgrenzen.eml

Von	praxis-ahrends@example.invalid
An	personalstelle@hafenpolizei.example
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	Wiedereingliederung Herr Jessen - Belastungsgrenzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die ersten vier Wochen empfehle ich Innendienst ohne Nacht- und Bereitschaftsdienste. Einsätze mit unmittelbarer Konfliktlage sollten vorerst vermieden werden. Eine Neubewertung kann nach vier Wochen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Merle Ahrends

Datei: 03-beihilfe-heilfuersorge-bescheide.csv

Datum;Bescheid;Betrag;Problem
12.12.2024;Psychotherapie abgelehnt;1.240 EUR;Kausalität verneint
18.02.2025;Fahrtkosten Heilverfahren teilweise;186 EUR;nur körperliche Folge anerkannt
21.04.2025;Wiedereingliederung ohne Zulagenklärung;0 EUR;Bezügefolge offen
05.05.2025;PKV verweist auf Dienstherrn;offen;Systembruch Beihilfe/Heilfürsorge

Tabellenblatt: Kosten

Position	Betrag	Status
Therapie	3240	streitig
Fahrtkosten	418	teilweise
Supervision	900	offen
Dienstsport-Reha	620	offen

Tabellenblatt: Dienst

Phase	Stunden	Zulagenfrage
Phase 1	4	Nachtdienstzulage entfällt?
Phase 2	6	Einsatzdienst noch ausgeschlossen
Phase 3	8	volle Dienstfähigkeit offen

Unfallanzeige und Einsatzbericht

Der Einsatzbericht beschreibt einen Brand in Halle 7, den Verdacht auf austretende Chemikalien und die Evakuierung eines verletzten Kollegen aus einem Rauchbereich. Behrens übernahm zeitweise die Abschnittsleitung, weil der reguläre Einsatzleiter im Funkloch war. Um 03:20 Uhr brach sie nach Rückkehr zur Wache kurz zusammen. In der Unfallanzeige wurden zunächst nur Rauchgas und Knieprellung eingetragen.

Die psychischen Symptome wurden erst später ergänzt. Die Dienststelle hält dies für verspätet. Die Mandantin erwidert, sie habe die Symptome zunächst als normale Einsatznachwirkung verstanden und erst nach ärztlicher Einordnung als mögliche Dienstunfallfolge gemeldet.

Ärztlicher Verlauf

Der Streit liegt nicht darin, ob Behrens krank ist. Der Streit liegt in der dienstunfallrechtlichen Kausalität und in der Frage, ob die Dienststelle die Behandlung als Unfallfürsorge steuern muss.

Datum	Dokument	Inhalt
15.09.2024	Durchgangs-/Notfallbericht	Rauchgasreizung, Prellung, Schlaflosigkeit erwähnt
10.10.2024	Hausärztliche Notiz	Alpträume und Konzentrationsprobleme
22.11.2024	Psychotherapeutische Erstdiagnostik	Verdacht PTBS, depressive Symptomatik
14.01.2025	Amtsärztliche Stellungnahme	Kausalität offen, private Belastungen erwähnt
03.04.2025	Fachgutachten	Ereignis geeignet, Verlauf plausibel, Wiedereingliederung empfohlen

Wiedereingliederungsplan Karla Behrens

Phase 1

Vier Wochen Innendienst ohne Nachtdienst, keine Gefahrguteinsätze, feste Ansprechpartnerin, wöchentliche Rückmeldung an Personalstelle und behandelnde Ärztin.

Phase 2

Steigerung auf sechs Stunden täglich, Teilnahme an Lagebesprechungen, aber keine alleinige Einsatzleitung. Parallel Supervision und Belastungstagebuch.

Rechtsfragen

BEM ist kein Ersatz für Dienstunfallanerkennung. Wiedereingliederung darf nicht als Beweis gegen fortbestehende Unfallfolgen verwertet werden, sondern soll Dienstfähigkeit erhalten.

Widerspruch gegen Teiablehnung psychischer Dienstunfallfolgen

Die Teiablehnung verengt den Dienstunfall auf körperliche Erstschäden. Sie setzt sich nicht hinreichend mit dem Einsatzgeschehen, der unmittelbaren Belastungsreaktion, der späteren fachärztlichen Einordnung und dem Verlauf auseinander. Dass private Belastungen vorhanden waren, schließt die wesentliche Mitursächlichkeit des Einsatzes nicht ohne weiteres aus.

Beantragt wird die Anerkennung der psychischen Gesundheitsstörung als Dienstunfallfolge, hilfsweise die Einholung eines unabhängigen fachpsychiatrischen Gutachtens mit konkreter Fragestellung. Zusätzlich werden Heilverfahrenskosten, Fahrtkosten, Wiedereingliederungsaufwand und die besoldungsrechtlichen Folgen der begrenzten Dienstfähigkeit geprüft.

Psychische Dienstunfallfolge und Kausalität

Der Mandant macht geltend, dass ein Einsatz bei der Hafenpolizei, die anschließende interne Aufarbeitung und eine fortgesetzte Überlastung zu einer psychischen Erkrankung geführt haben. Die Behörde trennt den einzelnen Einsatz vom späteren Burnout und erkennt nur eine kurzfristige Belastungsreaktion an.

Prüfungsproblem

Psychische Folgen können dienstunfallrechtlich relevant sein, wenn ein abgrenzbares Ereignis und eine zurechenbare Gesundheitsfolge nachweisbar sind. Schwieriger wird es, wenn sich ein einmaliges Ereignis mit Dauerbelastung, Führungsfehlern und privater Vorbelastung mischt. Dann muss die Akte medizinisch, dienstlich und zeitlich sehr sauber geführt werden.

Beweisfragen

Was war das konkrete Ereignis?

Welche Symptome traten wann auf?

Welche ärztlichen Befunde sind zeitnah?

Welche Belastungen sind allgemeiner Dienststress und welche unfallbezogen?

Welche Wiedereingliederung wurde angeboten?

Stufenweise Wiedereingliederung - Plan und Konflikt

Der Plan sieht zunächst vier Stunden Innendienst ohne Nachtschicht vor. Die Dienststelle möchte den Mandanten dagegen früh wieder in den Hafendienst einteilen, weil Personal fehlt. Die behandelnde Ärztin hält dies für zu früh.

Konfliktlinie

Die Dienststelle darf Funktionsfähigkeit beachten, muss aber Fürsorgepflicht und gesundheitliche Stabilisierung ernst nehmen. Ein Wiedereingliederungsplan, der faktisch wie volle Dienstfähigkeit behandelt wird, kann scheitern und spätere Dienstunfähigkeit vertiefen.

Praktische Maßnahmen

schriftliche Aufgabenbeschreibung,

keine spontanen Nachtschichten,

feste Ansprechpartnerin,

wöchentliche Rückmeldung,

Trennung zwischen Leistungsbewertung und Gesundheitsgespräch,

Dokumentation jeder Abweichung.

BEM-Gesprächsleitfaden Hafenpolizei

Das Gespräch beginnt mit der Frage, welche Tätigkeiten aktuell möglich sind, nicht mit dem Vorwurf hoher Fehlzeiten.

Gesundheitsdaten werden nur freiwillig und zweckgebunden besprochen. Die Personalstelle erhält keine Diagnosedetails, die für die Maßnahme nicht erforderlich sind.

Der Mandant soll konkrete Belastungen benennen: Nachtschicht, Einsatzort, Alleindienst, Konflikt mit Vorgesetztem, Wegzeiten.

Ziel ist eine belastbare Rückkehr, nicht ein schneller Statistik-Erfolg.

Widerspruch gegen Tei ablehnung der Unfallfürsorge

Der Bescheid erkennt nur eine kurzfristige Belastungsreaktion an und lehnt weitere Heilbehandlungskosten ab. Der Widerspruch rügt eine zu enge Kausalitätsbetrachtung. Die Behörde hat den zeitlichen Verlauf, die unmittelbaren ärztlichen Erstbefunde und die dienstliche Nachbelastung nicht vollständig gewürdigt.

Die Mandantenseite beantragt ein unabhängiges fachärztliches Gutachten, Einsicht in die Einsatznachbereitung und eine erneute Prüfung der Wiedereingliederungsmaßnahmen.

Hauptschriftsatz Dienstunfall, Burnout und Wiedereingliederung

Antrag und Ziel

Der Mandant begehrt die Anerkennung weiterer gesundheitlicher Folgen als dienstunfallbezogen, die Übernahme notwendiger Behandlungskosten und eine realistische stufenweise Wiedereingliederung. Der Fall ist nicht dadurch erledigt, dass die Behörde eine kurzfristige Belastungsreaktion anerkannt hat. Streiting ist, ob die späteren psychischen und funktionalen Einschränkungen dienstlich zurechenbar sind oder als allgemeine Erkrankung behandelt werden dürfen.

Sachverhalt

Der Mandant war bei einem belastenden Hafeneinsatz eingesetzt, bei dem eine Gefahrensituation, unklare Führungsentscheidungen und anschließende öffentliche Kritik zusammenkamen. Direkt danach traten Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Vermeidungsverhalten auf. Die Dienststelle wertete dies zunächst als vorübergehende Belastung. Später kam es zu längeren Ausfallzeiten. Eine strukturierte Nachsorge erfolgte nur bruchstückhaft.

Rechtliche Bewertung

Psychische Dienstunfallfolgen verlangen eine sorgfältige Kausalitätsprüfung. Die Behörde darf nicht pauschal sagen, Burnout sei immer allgemeiner Dienststress. Ebenso darf die Mandantenseite nicht jede spätere Belastung automatisch dem Einsatz zuordnen. Entscheidend sind zeitlicher Verlauf, Erstbefunde, Konsistenz der Symptome, dienstliche Nachbelastungen und fachärztliche Einschätzungen.

Wiedereingliederung

Die Wiedereingliederung ist kein Personalsteuerungsinstrument zur schnellen Rückkehr in den Schichtplan. Sie muss gesundheitlich tragfähig sein. Wenn der Plan Innendienst ohne Nachtschicht vorsieht, darf die Dienststelle nicht informell doch belastende Dienste anordnen. Jede Abweichung muss dokumentiert und medizinisch rückgekoppelt werden.

Datenschutz und Fürsorge

Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Personalstelle, Vorgesetzte und Kollegium benötigen nicht dieselben Informationen. Die Kanzlei achtet darauf, dass Diagnosen nicht unnötig verbreitet werden. Gleichzeitig darf Datenschutz nicht als Vorwand genutzt werden, um fehlende Fürsorgemaßnahmen unsichtbar zu machen.

Ergebnis

Die Behörde muss den Ursachenzusammenhang neu prüfen, die medizinische Begutachtung erweitern und die Wiedereingliederung verbindlich gestalten.

